

25- Notes Pratique avant l'Abord du Foie

Je ne travaille pas un organe, je travaille toujours un environnement. Et je suis très attentif d'être trop sélectif, trop local. Quand on voit le foie, il va aussi bien organiser l'arrière-cavité des épiplons que la mise en place de l'estomac, finalement l'axe pour la rate, que même finalement jusqu'au grand épiplon. On va faire une pratique sur le foie par rapport au cœur et par rapport à l'arrière-cavité des épiplons, mais dans une autre prise de main. Et on va simplement permettre au foie de retrouver sa motilité parce que c'est elle qui crée finalement sa fonction. On commence, c'est un neutre encore un peu superficiel. Mais le neutre de plus en plus profond, plus la respiration primaire vient se montrer. C'est vraiment cette rencontre de ces deux neutres qui fait émerger le processus thérapeutique. On a vu l'importance du foie. Il allait organiser aussi bien l'embryon dans son axe, l'axe transversal, avec la mise en place de ce qu'on appelle l'axe gastro-duodéno-pancréatico-linéal, tout ce mouvement. Et donc ça allait donner tout ce mouvement comme ceci. Cette bascule que vous avez commencé à comprendre hier avec le réseau veineux et artériel, c'est un mouvement développemental dans la croissance. Ce qui fait qu'effectivement il se déplace par là, mais il ne fait pas un mouvement de rotation. Il se déplace sur lui-même. Donc il a cette force de développement. Et ça c'est la motilité d'origine embryonnaire. Quand on va mettre ses mains, on va se mettre plutôt dans un fulcrum où c'est tout le système qui se développe. Si je me mets dans le local, je quitte le fulcrum originel. Plus tu t'approches du fulcrum embryonnaire, plus tu t'approches de cette force, plus le corps peut te donner l'information, parce qu'il connaît. Donc plus sa fréquence, plus la puissance régénératrice se fait. Prenez le mot aussi fulcrum, c'est une fonction. La ligne médiane, par exemple, c'est un fulcrum pour la totalité. Mais le fulcrum, ça peut être aussi comme un point d'appui, Je préfère une fonction. On voyait la zone du cœur où je dis tiens, ça c'est le fulcrum, ça c'est son arrivée. Donc c'est le fulcrum

embryonnaire. Je ne peux pas dire que c'est un point. Ce travail de bonne motilité du développement du cerveau, on va pouvoir vous en servir presque comme un outil. Rappelez-vous ces courbures, le tai chi du cerveau, expansion, flexion céphalique, flexion cervicale, flexion pontique et télancéphalisation. Cette phase de télancéphalisation est très importante. Elle va donner la phase de redressement et toute la mise en place de ma ligne blanche antérieure. ça veut dire à la fois l'étoile, qui à la fois se fait comme ceci et comme ceci. On peut travailler uniquement sur sa motilité ou alors on peut prendre des points spécifiques qui sont des points d'appui, comme ma pointe de monotocorte, comme le supraoccipute, comme la base occipute ou comme le préphénoïde qui seront en rapport avec ses développements. Par exemple, la pointe de monotocorte sera un des points de référence importants dans la flexion submésence céphalique. Donc je peux aller rechercher le point de silence. Dans le système en développement. Ça va dépendre des points d'appui sur lesquels je vais me mettre. Il y a des phases qui vont se faire ensemble. C'est la synchronicité du développement. Par rapport à ce développement du cerveau, le vestige important va se retrouver au niveau du système mésantérieur. On voit ici qu'on a un axe vitélin ou méसारéique qui va se retrouver. il faut aller rechercher ce qui s'est passé sur ce niveau-là comme référentiel. Comme plan pour aller redynamiser un cerveau en développement, par exemple. Sur le plan vasculaire. N'oubliez pas que le cerveau est complètement dépendant dans sa fonction et dans sa formation du cœur. C'est lui qui l'informe continuellement et on retrouve une pulsation dans le cerveau. Toujours bien à voir cette image ici où on voit ce septum transversum qui vient s'enrouler avec la mise en place du foie, etc. qui serait intégré avec cette vésicule vitéline. La mise en place de cette cavité amniotique qui est tout ce travail qu'on a fait hier. Il y a un mouvement de motilité développementale qui est généré par le foie

et qui va mettre en place tout ce système hépatogastro-diodéno-pancréatico-linéal. On a à la fois cette bascule du cœur, on va dire, sur son axe gauche, ce mouvement inverse au niveau hépatique global, et la contre-rotation sur le plan digestif. Là, vous avez les points d'appui et on va juste travailler d'abord sur ce grand centre d'organisation sous-diaphragmatique avec toute la mise en place finalement de l'arrière-cavité des épiploïdes. Puis on va voir comment ça va se présenter par rapport à mon foie et au cœur. Ce seront nos deux points qu'on va travailler. L'empreinte cardiaque, l'empreinte pulmonaire et l'énorme empreinte hépatique. On va faire un travail sur le foie en rapport avec la mise en place du cœur et de l'intestin et on va se mettre dans un processus dans l'idée de cette biodynamique. C'est-à-dire qu'on va mettre les mains et on va laisser le mouvement se faire. Là, on peut avoir un mouvement qui vient chercher ou on peut avoir un mouvement qui fait son originalité. On va donner ce point pour que le système puisse se réorganiser. Le foie, en fait, c'est une spécialisation. Il faut le voir comme une expansion fractale de l'intestin. C'est un ensemble de canaux biliaires avec deux types d'informations. Une information de type vasculaire. C'est là où tu as ce qu'on appelle le foie de type portal. Un visage tout rouge peut exprimer un problème hépatique de type mésodermique. Un visage tout jaune peut expliquer un problème hépatique de type endodermique. Ce sera deux façons de voir le système.